

प्यूबोसिम्फिज़ियल फिस्टुला (मूत्र-प्यूबिक हड्डी फिस्टुला)

WARWIKI

रोगी जानकारी · जब मूत्र प्यूबिक हड्डी में पहुँचकर दर्द और संक्रमण पैदा करता है

प्यूबोसिम्फिज़ियल फिस्टुला (जिसे यूरोसिम्फिज़ियल फिस्टुला भी कहते हैं) मूत्र मार्ग (मूत्राशय की गर्दन या मूत्रमार्ग) और प्यूबिक हड्डी के जोड़ के बीच एक असामान्य रास्ता है — आमतौर पर उस हड्डी में संक्रमण के साथ। इससे प्यूबिक या ग्रोइन में तीव्र दर्द और चलने में कठिनाई होती है। यह दुर्लभ और गंभीर है, पर इसका स्पष्ट इलाज मौजूद है।

इस स्थिति के बारे में

प्यूबिक हड्डी के संपर्क में मूत्र आने से हड्डी में संक्रमण (ऑस्टियोमाइलाइटिस) और जोड़ का क्षरण होता है। सामान्य लक्षण:

- **प्यूबिक, ग्रोइन या पेल्विक में तीव्र दर्द**, जो चलने पर बढ़ता है
- चलने या वज़न सहने में कठिनाई
- बार-बार UTI; कभी-कभी मूत्र रिसाव

इस दर्द को पहले अक्सर गठिया या हड्डी की समस्या समझ लिया जाता है, जिससे निदान में देर हो सकती है।

कारण

यह लगभग हमेशा **प्रोस्टेट कैंसर के इलाज** — विशेषकर **रेडिएशन** — की देर से आने वाली जटिलता है, अक्सर मूत्राशय की गर्दन या मूत्रमार्ग पर पहले की कोई प्रक्रिया के बाद। रेडिएशन से प्रभावित ऊतक ठीक से नहीं भरते, जिससे मूत्र हड्डी तक पहुँच जाता है।

शब्दों को समझें

Pubic symphysis

वह जोड़ जहाँ प्यूबिक हड्डियाँ पेल्विस के सामने मिलती हैं।

प्यूबोसिम्फिज़ियल फिस्टुला

मूत्र मार्ग और उस जोड़/हड्डी के बीच असामान्य रास्ता।

ऑस्टियोमाइलाइटिस

हड्डी का संक्रमण।

MRI

हड्डी और फिस्टुला दिखाने के लिए सबसे अच्छा scan।

Debridement

संक्रमित हड्डी और ऊतक को सर्जरी से हटाना।

मूत्र डायवर्ज़न

मूत्र को क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रोककर नया रास्ता बनाना — अक्सर स्थायी समाधान।

इसका इलाज इतनी तेज़ी से क्यों किया जाता है? क्योंकि समस्या **संक्रमित, ठीक न होने वाले (अक्सर रेडिएशन से प्रभावित) ऊतक और हड्डी** में है; सिर्फ पैच करना शायद ही काम आता है। स्थायी राहत के लिए संक्रमित हड्डी हटाकर **मूत्र को उस क्षेत्र से दूर रोकना** ज़रूरी है — इसीलिए मूत्र डायवर्ज़न अक्सर सुझाया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि वर्षों का दर्द आखिरकार ख़त्म हो सकता है।

जाँच कैसे होती है

- पेल्विस का **MRI** (हड्डी देखने के लिए सबसे अच्छा) और मूत्रमार्ग/मूत्राशय की जाँच
- संक्रमण पहचानने के लिए culture test
- विस्तृत इतिहास — पूर्व प्रोस्टेट कैंसर उपचार, रेडिएशन और प्रक्रियाएँ

इलाज कैसे होता है

- 1 हड्डी के संक्रमण के लिए **एंटीबायोटिक्स**।
- 2 संक्रमित हड्डी हटाने (**debridement**) और क्षेत्र साफ़ करने की **सर्जरी**।
- 3 **मूत्र का रास्ता बदलना** — कई पुरुषों को अंततः **मूत्र डायवर्ज़न** (और कभी-कभी क्षतिग्रस्त मूत्राशय/मूत्रमार्ग को हटाना) की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेडिएशन से प्रभावित ऊतक अन्यथा नहीं भरते।
- 4 **टिशू फ्लैप** — खाली जगह भरने और ठीक करने के लिए स्वस्थ मांसपेशी या omentum लाया जा सकता है।

देखभाल आमतौर पर **बहु-विशेषज्ञ** (यूरोलॉजी के साथ ऑर्थोपेडिक और/या प्लास्टिक सर्जरी) टीम करती है।

ज़रूरी बातें

- यदि प्रोस्टेट रेडिएशन के बाद बिना कारण प्यूबिक दर्द हो, तो अपनी टीम को बताएँ — इसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है।
- मूत्र डायवर्ज़न कठिन लग सकता है, पर यही अक्सर **दर्द और संक्रमण से स्थायी राहत** देता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **बुखार, ठंड लगना या बहुत अस्वस्थ महसूस होना** (फैलता संक्रमण हो सकता है)
- **प्यूबिक/ग्रोइन दर्द का बढ़ना या चलने में असमर्थता**
- **पेशाब न हो पाना या अधिक रक्तस्राव**

याद रखने योग्य तीन बातें

1. प्यूबोसिम्फिज़ियल फिस्टुला में मूत्र प्यूबिक हड्डी को क्षत करता है, जिससे तीव्र दर्द और हड्डी में संक्रमण होता है — आमतौर पर प्रोस्टेट रेडिएशन के वर्षों बाद।
2. इसे अक्सर गठिया समझ लिया जाता है; MRI से निदान होता है। अपनी टीम को पूर्व रेडिएशन ज़रूर बताएँ।
3. इलाज में संक्रमित हड्डी हटाना और आमतौर पर मूत्र डायवर्ज़न शामिल है — कठोर, पर यह दर्द को आखिरकार समाप्त कर सकता है।